

CAPÍTULO 14.21

Fibromialgia

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción

La **fibromialgia** es un síndrome de dolor crónico no articular, caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado y una reducción del umbral del dolor. A diferencia de otras patologías reumatológicas, **no es una enfermedad autoinmune ni inflamatoria**, sino que se entiende actualmente como un trastorno de la regulación del dolor y la sensibilización central.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: Aunque no se conoce con exactitud, se relaciona estrechamente con una **mala regulación neuromuscular durante el sueño** y alteraciones del ciclo circadiano. Esto genera un estado de hiperalergia y una atención selectiva aumentada sobre los estímulos musculares, transformando sensaciones normales en dolorosas.

Cuadro Clínico

La clave de la fibromialgia es su presentación clínica multisistémica. El diagnóstico es **fundamentalmente clínico**.

1. Dolor Generalizado

Es el síntoma cardinal. Es un **dolor muscular**, no articular. El paciente suele describir que "le duele todo el cuerpo". -

Localización común: Cuello, trapecios, supraespinosos, pectorales, glúteos, trocánter, cara interna de la rodilla, parte lateral del codo y antebrazos. - **Puntos sensibles:** Históricamente se usaban 18 puntos específicos, pero actualmente se considera que el dolor puede afectar a cualquier grupo muscular de forma difusa.

2. Alteraciones del Sueño y Fatiga

- **Sueño no reparador:** El paciente despierta cansado independientemente de las horas dormidas. - **Fatiga (Astenia):** Sensación de falta de fuerzas constante ("no tengo fuerzas para nada").

3. Comorbilidades Psiquiátricas

Existe una alta asociación con: - **Depresión**. - **Trastornos de Ansiedad**. - Estrés crónico.

Diagnóstico y Exámenes Complementarios

El diagnóstico se basa en la historia clínica de dolor generalizado (más de 3 meses) sin otra causa que lo explique. Los exámenes de laboratorio suelen estar **normales**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡No pedir de más! Es un error común solicitar marcadores inmunológicos como ANA o Factor Reumatoide si no hay clínica sugerente de **Lupus Eritematoso Sistémico** o **Artritis Reumatoide**. En la fibromialgia, estos serán negativos o positivos inespecíficos, confundiendo el diagnóstico.

Laboratorio Básico de Descarte

Se recomienda solicitar un set mínimo de exámenes para descartar "imitadores" de la fibromialgia:

TABLA 14.21.1: EXAMEN VS OBJETIVO

EXAMEN	OBJETIVO
Hemograma y VHS	Descartar procesos inflamatorios o infecciosos ocultos.
Proteína C Reactiva (PCR)	Descartar inflamación sistémica.
TSH	El Hipotiroidismo puede manifestarse con mialgias y fatiga.
Creatinfosfoquinasa (CK)	Descartar miopatías inflamatorias como la Polimiositis .

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si la VHS está muy elevada, sospeche **Polimialgia Reumática** (especialmente en adultos mayores) o neoplasias, no fibromialgia.

Pilares del Tratamiento

El manejo debe ser multidisciplinario y centrado en la funcionalidad del paciente.

1. Educación y Estilo de Vida

Es el paso más importante. El paciente debe comprender que su dolor es real pero no destructivo (no daña las articulaciones ni los órganos). - **Higiene del sueño:** Corregir hábitos para lograr un sueño reparador. - **Ejercicio físico:** Es la intervención con mayor evidencia. Se recomiendan ejercicios de **estiramiento y fortalecimiento muscular**. - *Pearl:* "Si le va a doler el cuerpo, que sea porque hizo ejercicio y no por nada".

2. Farmacoterapia (Neuromoduladores)

Se utilizan para modular la percepción del dolor y mejorar el sueño.

TABLA 14.21.2: GRUPO FARMACOLÓGICO VS EJEMPLOS

GRUPO FARMACOLÓGICO	EJEMPLOS	UTILIDAD
Antidepresivos Tricíclicos	Amitriptilina (dosis bajas)	Primera línea. Mejora el dolor y la arquitectura del sueño.
Moduladores del Dolor	Pregabalina, Gabapentina	Útiles si hay contraindicación para tricíclicos o dolor neuropático asociado.
Antidepresivos Duales	Duloxetina, Milnaciprán	Útiles en pacientes con depresión concomitante o en adultos mayores (más seguros).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Evite el uso de opioides potentes y corticoides en la fibromialgia; no han demostrado eficacia y aumentan el riesgo de efectos adversos y dependencia.

Consideraciones para el EUNACOM

- El diagnóstico es de **exclusión** de otras patologías orgánicas, pero basado en una **clínica positiva** de dolor muscular y puntos sensibles. - Los pacientes pueden ser muy demandantes debido al impacto en su calidad de vida; la respuesta médica debe ser empática pero firme en **no realizar sobre-estudio** innecesario. - Siempre descarte **Hipotiroidismo** ante un cuadro de mialgias y fatiga. - El ejercicio aeróbico y de resistencia es el tratamiento no farmacológico más efectivo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 45 años con dolor muscular generalizado, alteraciones del sueño y ánimo depresivo. Hemograma, PCR, CK y TSH normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Fibromialgia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- No es enfermedad autoinmune; se relaciona con mala regulación neuromuscular del sueño
- Clínica cardinal: dolor muscular generalizado (no articular) sin otra causa que lo explique
- Diagnóstico absolutamente clínico; exámenes de sangre normales
- Solo pedir: hemograma, PCR, TSH y CK. No pedir ANA ni factor reumatoide
- Tratamiento: educación + ejercicio + neuromoduladores (amitriptilina, pregabalina, duloxetine)
- No pedir exámenes innecesarios aunque el paciente los demande

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FIBROMIALGIA)**PREGUNTA 1**

Paciente de 45 años con dolor muscular generalizado, alteraciones del sueño y ánimo depresivo. Hemograma, PCR, CK y TSH normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Polimiositis
- B)** Polimialgia reumática
- C)** Lupus eritematoso sistémico
- D)** Fibromialgia
- E)** Hipotiroidismo

PREGUNTA 2

¿Cuál de los siguientes exámenes NO debe solicitarse de rutina en la evaluación de fibromialgia?

- A)** Hemograma
- B)** PCR
- C)** ANA
- D)** TSH
- E)** CK

PREGUNTA 3

¿Cuál es el fármaco de primera línea para el manejo farmacológico de la fibromialgia?

- A)** Prednisona
- B)** Ibuprofeno
- C)** Amitriptilina
- D)** Metotrexato
- E)** Hidroxicloroquina

RESUMEN: FIBROMIALGIA

La fibromialgia no es una enfermedad autoinmune; su fisiopatología probablemente se relaciona con mala regulación neuromuscular durante el sueño. La clínica incluye alteraciones del sueño, fatiga, astenia, comorbilidad psiquiátrica (depresión, trastornos ansiosos) y, lo más importante, dolor muscular generalizado (no articular) que se reproduce a la compresión de diversos grupos musculares (trapecios, supraespinosos, pectorales, glúteos, muslos, antebrazos, cuello, etc.). El diagnóstico es absolutamente clínico: dolor generalizado sin otra causa que lo explique. Los exámenes están todos normales; se recomienda pedir solo hemograma, PCR (descartar patología inflamatoria), TSH (descartar hipotiroidismo) y CK (descartar polimiositis). No pedir marcadores inmunológicos (ANA, factor reumatoide). El tratamiento se basa en educación, ejercicio (estiramiento y fortalecimiento muscular), y neuromoduladores: antidepresivos tricíclicos (amitriptilina), pregabalina/gabapentina, o antidepresivos duales (duloxetine, milnaciprán). Es fundamental no pedir exámenes innecesarios.